جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منى دياب عباس ابراهيم
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** --
رقم البطاقة : 27510150104742 **رقم التليفون :** 01150727018 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 15-10-1975 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) [14152] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منى دياب عباس ابراهيم
National ID: 27510150104742

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Docetaxel chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



منى
دياب عباس ابراهيم
٥ ش فريد مهدى
حلوان - القاهره

٢٧٥ ١٠ ١٥ ٠١٠٤٧ ٤٢

LW7496030

DMS
تدعيم
مقطعية صدر بالخروج

٢٧٥١٠١٥٠١٠٤٧٤٢ ٢٠٢٦/٠٨
ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
هاشم محمود احمد حسين
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٨/٠١

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

معمل حلوان للتحاليل الباثولوجية والانسجة

Prof. Dr. Samia Mohamed Gabal
M.D and Consultant of Pathology.
Professor of Pathology, Faculty of Medicine,
Cairo University.

ا.د/ سامية محمد جبل
دكتوراه واستشاري الباثولوجيا
أستاذ الباثولوجيا - كلية الطب جامعة القاهرة

PATHOLOGY REPORT

Name: مني دياب عباس
Age: 50 Y
Specimen: Right breast mass.

No: 472/2026
Referred by: Prof.Dr. Hossam Alsayed
Date: 23/7/2026

GROSS:

Three small greyish tan tissue cores measuring 0.5-1 cm long totally submitted

MICROSCOPIC:

Examination of sections prepared from the biopsy received revealed two cores of tumor tissue formed of cords highly atypical epithelioid cell with large pleomorphic hyperchromatic nuclei, some showed eccenteric nucleus and eosinophilic cytoplasm, they show crushing atrifact. They are surrounded by desmoplasia. Core was fromed of adipose tissue is also seen.

DIAGNOSIS:

RIGHT BREAST MASS, US GUIDED TRUE CUT BIOPSY:

- *PICTURE IS OF INFILTRATING PLEOMORPHIC LOBULAR CARCINOMA, GRADE 2.*
- *NO EVIDENCE OF IN SITU COMPONENT.*
- *NO INTRATUMORAL STROMAL LYMPHOCYTIC INFILTRATION IN THIS BIOPSY.*
- *FOR (CK, ER , PR , HER2 AND KI67).*

One slide enclosed.

Prof. Dr. Samia M. Gabal

٢٧ ب شارع اسماعيل كامل- خلف عمارات المروة- حلوان ت:٢٨١٦٠٥٢٥ - ٠١١٤٩٠١٩٥١٠

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: MRS/ MONA DIAB **Date:** 4 July 2026

REAL TIME RIHGT BREAST ULTRASOUND

- The right breast reveals ,smooth regular contour with mild diffuse hypertrophy of the glandular elements
- Dilated caliber of duct system , large one about 2.4 mm, normal up to 2 mm .
- Evidence of lower outer quadrant lesion at 8 o'clock location of irregular outline, hypoechoic ,fuzzy outline , preserving the adjacent parenchyma ,& its architecture , it measures about 19x26x41 mm in its max. dimensions . it reveals vascularity on Duplex scanning, , interstitial edema , and at subcutaneous tissue , nipple and areola.
- Evidence of large axillary lobulated lesions , large one measuring about 21x 7 mm with scattered echogenic lines , likely matted lymphadenopathies

OPINION :

- ***Right breast solid lesion with site , size , extension and echogenicity as forementioned , data consistent with neoplastic growth (BIRAD IV) , for correlation with clinical , and histopathological verification***

Much obliged,
Dr. EMAN KAMAL

NAME:	**Mrs MONA DIAB ABBAS**
DATE:	**21 July 2026**

Dear Dr SIR;

Thanks for referral of this kind lady;

US GUIDED TRUE CUT CORE BIOPSY FROM THE RIGHT LOQ MASS:-

- **Under US guidance and infiltration local anesthesia.**
- **16 G needle was introduced into the Right breast LOQ mass lesion.**
- **Two 2 cm each tissue was acquired and preserved in formaldhyde solution for your kind care and histopathologic examination and assessment.**

- ***FOR HISTOPATHOLOGY ASSESSMENT***
- ***HER-2 Receptors EXAMINATION.***
- *Clinical background:-*

  Right Breast mass wa developed over at least 7 months and slowly growing as described by the patient with pae d'orange skin dimpling, US hypoechoic mass 4 x 1.3 cm, mammography showed an ill defined slightly dense heterogeneous mass.

Truly yours

Dr. Waseem El Gendy, MD

Ultrasound
[[DOCTYPE:ULTRASOUND]]

[[DOCTYPE:MDT_FORM]]
MDT Form

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنك المصري لدعم صحة مصر

10/11/2026

MDT FORM

Name:	ملى دياب عباس ابراهيم	**MRN:**	12975
Age:	51 Y	**ID:**	27510150104742
Menopausal Sta	POST MENOPASUAL	**Phone:***	01150727018
NRS SCORE:		**Marital Status:**	MARRIED
BMI:		**Family History:**	POSITIVE
Gender			
CO Morbidity:	FREE	**Reason Of MDT:**	NEW
Surgical History:*	HX OF ECTOPIC PREGNANCY	**ECOG Performance Status**	◉ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX: INVASIVE LOBULAR CARCINOMA

ER: 0/8 **PR:** 0/8 **HER2:** 3+ **KI67:** 15%

History:

Sonomammography:
RT BREAST 8 TO 9 OCLOCK AREA OF HYPOECHOIC ALTERATION AND PARENCHYMAL DISTORTION
DIFFUSE RT BREAST EDEMA AND SKIN THICKENING
MULTIPLE RT AXILLARY LYMPH NODES

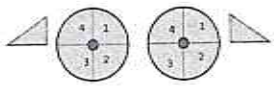
Biomarker/Molecular

Mets Workup:
CT CAP >>>>ADRENAL HYPERPLASIA
BONE SCAN >>>>BENIGN LOOKING LESION AT D 10 FOR FOLLOW UP

Recommendations:
FOR NACT THEN RT MRM AFTER ASSESEMENT OF RESPONSE

MDT Outcome & Plan
FOR *CESM (CONTRALATERAL ASSESSMENT)
*PORTA CATH - ECHO
*TCHP X 6 CYCLES AND US LOCO-REGIONAL ASSESSMENT /2CYCLES
+ THEN RT MRM

R L



TNM

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:
T4d N 2

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د.ندي حسن	د.محمد النيراوي		